

BioMaster 候选精简专家可行性复核

这版按“GPT 高强度人工复核”的方式重读五个疾病方向各 Top10 候选：不再把分数当结论，而是逐项判断这个组合是什么意思、是否像新发现、第一步怎么验证、为什么可能不值得做。结论仍然是计算优先级和专家审阅建议，不是生物学验证结果。

50 候选	5 疾病方向	3 优先讨论	0 暂缓/不首轮
----------	-----------	-----------	-------------

核心口径。先看这个候选能否被一个直接、便宜、可解释的靶点实验验证；再看疾病背景和已有文献。如果已经是老机制，就只作阳性对照；如果疾病解释链弱或同一药物反复命中许多弱相关靶点，就先暂缓。

生成时间：2026-06-05 09:58 UTC。长版数据 PDF 和 literature audit CSV 仍保留为证据备查。

专家阅读说明

亲和分

说明模型认为药物和蛋白可能相互作用。它是筛选信号，不代表真实 IC50，也不代表体内有效。

疾病证据

Open Targets、TxGNN 和 KG 说明靶点或药物是否和疾病方向有知识图谱关系。它能帮助解释，但不能替代实验。

CMap/CREEDS

看药物表达签名是否可能反转疾病签名。它是方向性线索，受细胞系、剂量和时间影响很大。

GTEX/HPA/DepMap

帮助判断靶点在哪些组织或疾病模型中表达，以及肿瘤中是否有依赖性。主要用于选模型。

DiffDock

看结构姿态是否可讨论。负数 confidence 不是坏事，也不是结合自由能；只能作为结构审阅辅助。

GPT 审阅

把上述证据合并成实际判断：先做哪个、哪些只作对照、哪些容易浪费实验预算。

建议首轮实验组合

50 个候选不建议一起做。首轮应由少量“正控/校准”证明实验体系有效，再选择能用低成本靶点实验判定真假的探索候选。下面清单是本次 GPT 复核后建议优先给专家讨论的组合。

用途	方向	候选	判断	第一步实验
正控/校准	心血管	Gefitinib EGFR	作为阳性对照保留，不作为候选发现。	纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
正控/校准	心血管	Dorzolamide Hydrochloride CA2	适合作为 enzyme assay 阳性对照。	CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。
正控/校准	免疫/炎症	Dorzolamide Hydrochloride CA2	适合作为 enzyme assay 阳性对照。	CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。
正控/校准	感染性疾病	Dorzolamide Hydrochloride CA2	适合作为 enzyme assay 阳性对照。	CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。
正控/校准	神经/精神	Gefitinib EGFR	作为阳性对照保留，不作为候选发现。	纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
正控/校准	肿瘤	Gefitinib EGFR	作为阳性对照保留，不作为候选发现。	纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

首轮解释。正控不是发现结果，而是证明 assay 和读数能工作；探索候选也不应直接进入复杂疾病模型，应先用 target engagement、功能 readout 和 counterscreen 判断是否值得继续。

候选总览

疾病方向分布: {"肿瘤": 10, "感染性疾病": 10, "心血管": 10, "神经/精神": 10, "免疫/炎症": 10}。GPT 审阅分类: {"二线探索": 29, "阳性对照/校准": 17, "优先专家讨论": 3, "机制延展/先排重": 1}。

#	方向	候选	GPT 分类	专家先看这一句	建议
1	肿瘤 Top 1	Gefitinib EGFR	阳性对照/ 校准	这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。	作为阳性对照保留，不作为候选发现。
2	肿瘤 Top 2	Cladribine GCGR	优先专家 讨论	Cladribine 指向 GCGR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	建议进入专家讨论，但先做低成本靶点实验。
3	肿瘤 Top 3	Palonosetron Hydrochloride F2R	二线探索	Palonosetron Hydrochloride 指向 F2R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
4	肿瘤 Top 4	Dasatinib YES1	阳性对照/ 校准	Dasatinib 指向 YES1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
5	肿瘤 Top 5	Bosutinib Monohydrate EPHB4	二线探索	Bosutinib Monohydrate 指向 EPHB4 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
6	肿瘤 Top 6	Imatinib Mesylate KIT	阳性对照/ 校准	Imatinib Mesylate 指向 KIT 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
7	肿瘤 Top 7	Fludarabine Phosphate ADORA1	二线探索	Fludarabine Phosphate 指向 ADORA1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
8	肿瘤 Top 8	Granisetron SLC6A4	二线探索	Granisetron 指向 SLC6A4 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
9	肿瘤 Top 9	Alvimopan P2RY2	二线探索	Alvimopan 指向 P2RY2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
10	肿瘤 Top 10	Sumatriptan Succinate GNRHR	二线探索	Sumatriptan Succinate 指向 GNRHR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
11	感染性疾病 Top 1	Gefitinib EGFR	机制延展/ 先排重	EGFR 是上皮细胞信号和部分感染模型中可讨论的宿主通路，但 Gefitinib-EGFR 本身是已知强机制。	先做文献排重；若专家关心宿主 EGFR 依赖感染模型，可作机制延展对照。
12	感染性疾病 Top 2	Dasatinib FYN	阳性对照/ 校准	Dasatinib 指向 FYN 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
13	感染性疾病 Top 3	Donepezil Hydrochloride EDNRA	二线探索	Donepezil Hydrochloride 指向 EDNRA 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
14	感染性疾病 Top 4	Sumatriptan Succinate AVPR1A	二线探索	Sumatriptan Succinate 指向 AVPR1A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
15	感染性疾病 Top 5	Tivozanib Hydrochloride CSF1R	二线探索	Tivozanib Hydrochloride 指向 CSF1R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
16	感染性疾病 Top 6	Dorzolamide Hydrochloride CA2	阳性对照/ 校准	这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。	适合作为 enzyme assay 阳性对照。
17	感染性疾病 Top 7	Atropine EDNRB	二线探索	Atropine 指向 EDNRB 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
18	感染性疾病 Top 8	Alvimopan ADORA2B	二线探索	Alvimopan 指向 ADORA2B 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
19	感染性疾病 Top 9	Palonosetron Hydrochloride CALCRL	二线探索	Palonosetron Hydrochloride 指向 CALCRL 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
20	感染性疾病 Top 10	Pazopanib Hydrochloride FLT3	二线探索	Pazopanib Hydrochloride 指向 FLT3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
21	心血管 Top 1	Donepezil Hydrochloride EDNRA	二线探索	Donepezil Hydrochloride 指向 EDNRA 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
22	心血管 Top 2	Gefitinib EGFR	阳性对照/ 校准	这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。	作为阳性对照保留，不作为候选发现。
23				这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。	适合作为 enzyme assay 阳性对照。

#	方向	候选	GPT 分类	专家先看这一句	建议
	心血管 Top 3	Dorzolamide Hydrochloride CA2	阳性对照/ 校准		
24	心血管 Top 4	Ramipril GLP1R	二线探索	Ramipril 指向 GLP1R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
25	心血管 Top 5	Spironolactone AR	阳性对照/ 校准	Spironolactone 指向 AR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
26	心血管 Top 6	Propranolol Hydrochloride HTR4	优先专家 讨论	Propranolol Hydrochloride 指向 HTR4 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	建议进入专家讨论，但先做低成本靶点实验。
27	心血管 Top 7	Treprostinil OPRM1	二线探索	Treprostinil 指向 OPRM1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
28	心血管 Top 8	Doxazosin Mesylate ADRB2	二线探索	Doxazosin Mesylate 指向 ADRB2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
29	心血管 Top 9	Labetalol Hydrochloride ADRB1	阳性对照/ 校准	Labetalol Hydrochloride 指向 ADRB1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
30	心血管 Top 10	Sacubitril NPY5R	二线探索	Sacubitril 指向 NPY5R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
31	神经/ 精神 Top 1	Gefitinib EGFR	阳性对照/ 校准	这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。	作为阳性对照保留，不作为候选发现。
32	神经/ 精神 Top 2	Methylnaltrexone Bromide OXTR	二线探索	Methylnaltrexone Bromide 指向 OXTR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
33	神经/ 精神 Top 3	Atropine CHRM1	阳性对照/ 校准	Atropine 指向 CHRM1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
34	神经/ 精神 Top 4	Solifenacin Succinate CHRM3	阳性对照/ 校准	Solifenacin Succinate 指向 CHRM3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
35	神经/ 精神 Top 5	Amisulpride ADRA1A	二线探索	Amisulpride 指向 ADRA1A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
36	神经/ 精神 Top 6	Dextromethorphan Hydrobromide KCNK9	二线探索	Dextromethorphan Hydrobromide 指向 KCNK9 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
37	神经/ 精神 Top 7	Nalmefene Hydrochloride DRD2	二线探索	Nalmefene Hydrochloride 指向 DRD2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
38	神经/ 精神 Top 8	Lumateperone Tosylate TACR3	二线探索	Lumateperone Tosylate 指向 TACR3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
39	神经/ 精神 Top 9	Umeclidinium Bromide CHRM2	阳性对照/ 校准	Umeclidinium Bromide 指向 CHRM2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。
40	神经/ 精神 Top 10	Revefenacin HTR2A	优先专家 讨论	Revefenacin 指向 HTR2A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	建议进入专家讨论，但先做低成本靶点实验。
41	免疫/ 炎症 Top 1	Dacomitinib EGFR	阳性对照/ 校准	这是已知 EGFR 抑制剂与 EGFR 的直接召回，和 Gefitinib 类似。	若预算有限，可在 EGFR 正控中只保留一个代表。
42	免疫/ 炎症 Top 2	Olopatadine Hydrochloride S1PR1	二线探索	Olopatadine Hydrochloride 指向 S1PR1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
43	免疫/ 炎症 Top 3	Palonosetron Hydrochloride F2R	二线探索	Palonosetron Hydrochloride 指向 F2R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
44	免疫/ 炎症 Top 4	Sumatriptan Succinate SSTR3	二线探索	Sumatriptan Succinate 指向 SSTR3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
45	免疫/ 炎症 Top 5	Dasatinib YES1	阳性对照/ 校准	Dasatinib 指向 YES1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。

#	方向	候选	GPT 分类	专家先看这一句	建议
46	免疫/炎症 Top 6	Bosutinib Monohydrate FYN	二线探索	Bosutinib Monohydrate 指向 FYN 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
47	免疫/炎症 Top 7	Tivozanib Hydrochloride CSF1R	二线探索	Tivozanib Hydrochloride 指向 CSF1R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
48	免疫/炎症 Top 8	Azelastine Hydrochloride CXCR2	二线探索	Azelastine Hydrochloride 指向 CXCR2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。
49	免疫/炎症 Top 9	Dorzolamide Hydrochloride CA2	阳性对照/校准	这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。	适合作为 enzyme assay 阳性对照。
50	免疫/炎症 Top 10	Umeclidinium Bromide CHRM3	阳性对照/校准	Umeclidinium Bromide 指向 CHRM3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。	只作阳性对照或流程校准。

逐项 GPT 可行性复核

肿瘤 TOP 1

阳性对照/校准

Gefitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。

GPT 可行性判断：作为阳性对照保留，不作为候选发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 6,919, drug-target-disease 6,705, ClinicalTrials 药物-疾病方向 471。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Gefitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.963, affinity 0.971, DiffDock -0.96。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

肿瘤 TOP 2

优先专家讨论

Cladribine - GCGR

Glucagon receptor

专家先看这一句：Cladribine 指向 GCGR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：建议进入专家讨论，但先做低成本靶点实验。

为什么可以考虑：新颖性较高，且靶点功能实验相对可执行；适合 **为什么可能不值得做：**不要直接做疾病细胞表型；如果靶点先用低成本实验判断是否有真实 target engagement。readout 不成立，后续疾病实验没有解释力。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：GCGR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 147。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Cladribine 是否能产生 GCGR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.760, affinity 0.662, DiffDock -1.79。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Palonosetron Hydrochloride - F2R

Proteinase-activated receptor 1

专家先看这一句：Palonosetron Hydrochloride 指向 F2R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：F2R 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0，drug-target-disease 0，ClinicalTrials 药物-疾病方向 103。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Palonosetron Hydrochloride 是否能产生 F2R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.867，affinity 0.912，DiffDock -1.08。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dasatinib - YES1

Tyrosine-protein kinase Yes

专家先看这一句：Dasatinib 指向 YES1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：围绕 YES1/Tyrosine-protein kinase Yes 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 29，drug-target-disease 29，ClinicalTrials 药物-疾病方向 403。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dasatinib 是否能产生 YES1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.869，affinity 0.916，DiffDock -2.88。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Bosutinib Monohydrate - EPHB4

Ephrin type-B receptor 4

专家先看这一句：Bosutinib Monohydrate 指向 EPHB4 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 EPHB4/Ephrin type-B receptor 4 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0，drug-target-disease 0，ClinicalTrials 药物-疾病方向 1。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Bosutinib Monohydrate 是否能产生 EPHB4 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.815，affinity 0.802，DiffDock -0.66。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Imatinib Mesylate - KIT

Mast/stem cell growth factor receptor Kit

专家先看这一句：Imatinib Mesylate 指向 KIT 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 KIT kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 3,367, drug-target-disease 3,195, ClinicalTrials 药物-疾病方向 781。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Imatinib Mesylate 是否能产生 KIT 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.910, affinity 0.865, DiffDock -4.95。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Fludarabine Phosphate - ADORA1

Adenosine receptor A1

专家先看这一句：Fludarabine Phosphate 指向 ADORA1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 ADORA1/Adenosine receptor A1 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 2,465。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Fludarabine Phosphate 是否能产生 ADORA1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.836, affinity 0.812, DiffDock -0.47。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Granisetron - SLC6A4

Sodium-dependent serotonin transporter

专家先看这一句：Granisetron 指向 SLC6A4 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：SLC6A4 转运功能实验，检测 5-HT uptake 的抑制或调节。

Go/No-Go 门槛：只有在转运体依赖 readout、表达依赖性和非毒性窗口一致时推进。

排重状态：有少量文献线索。PubMed drug-target 7, drug-target-disease 2, ClinicalTrials 药物-疾病方向 76。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Granisetron 是否能产生 SLC6A4 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.869, affinity 0.858, DiffDock -2.25。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Alvimopan - P2RY2

P2Y purinoceptor 2

专家先看这一句：Alvimopan 指向 P2RY2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：围绕 P2RY2/P2Y purinoceptor 2 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 12。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Alvimopan 是否能产生 P2RY2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.863, affinity 0.921, DiffDock -3.96。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Sumatriptan Succinate - GNRHR

Gonadotropin-releasing hormone receptor

专家先看这一句：Sumatriptan Succinate 指向 GNRHR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：GNRHR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 2。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Sumatriptan Succinate 是否能产生 GNRHR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.735, affinity 0.879, DiffDock -0.61。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Gefitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：EGFR 是上皮细胞信号和部分感染模型中可讨论的宿主通路，但 Gefitinib-EGFR 本身是已知强机制。

GPT 可行性判断：先做文献排重；若专家关心宿主 EGFR 依赖感染模型，可作机制延展对照。

为什么可以考虑：机制上可解释，适合用来补充已知药理边界，但公开线索较多，发现价值有限。

为什么可能不值得做：如果人工确认已有直接机制验证，应降级为背景材料或忽略。

主要混杂因素：激酶药常有多靶点性质，需要 kinase panel 和通路 readout 区分真实靶点与相邻激酶抑制。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 6,919, drug-target-disease 169, ClinicalTrials 药物-疾病方向 30。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Gefitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.971, DiffDock -0.97。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dasatinib - FYN

Tyrosine-protein kinase Fyn

专家先看这一句：Dasatinib 指向 FYN 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：围绕 FYN/Tyrosine-protein kinase Fyn 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 42, drug-target-disease 5, ClinicalTrials 药物-疾病方向 32。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dasatinib 是否能产生 FYN 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.822, affinity 0.942, DiffDock -0.49。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Donepezil Hydrochloride - EDNRA

Endothelin-1 receptor

专家先看这一句：Donepezil Hydrochloride 指向 EDNRA 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：EDNRA 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 337。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Donepezil Hydrochloride 是否能产生 EDNRA 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.793, affinity 0.902, DiffDock -3.91。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Sumatriptan Succinate - AVPR1A

Vasopressin V1a receptor

专家先看这一句：Sumatriptan Succinate 指向 AVPR1A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：AVPR1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 116。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Sumatriptan Succinate 是否能产生 AVPR1A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.771, affinity 0.871, DiffDock -0.54。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Tivozanib Hydrochloride - CSF1R

Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor

专家先看这一句：Tivozanib Hydrochloride 指向 CSF1R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 CSF1R/Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 1。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Tivozanib Hydrochloride 是否能产生 CSF1R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.769, affinity 0.868, DiffDock -2.54。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

Carbonic anhydrase 2

专家先看这一句：这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。

GPT 可行性判断：适合作为 enzyme assay 阳性对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。

Go/No-Go 门槛：必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout；若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 47, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dorzolamide Hydrochloride 是否能产生 CA2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.830, affinity 0.953, DiffDock -0.10。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Atropine - EDNRB

Endothelin receptor type B

专家先看这一句：Atropine 指向 EDNRB 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：Atropine 的抗胆碱能主药理很强，DRD/HTR 等新假设必须先和 muscarinic receptor 效应区分。

第一步实验：EDNRB 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：有少量文献线索。PubMed drug-target 7, drug-target-disease 3, ClinicalTrials 药物-疾病方向 156。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Atropine 是否能产生 EDNRB 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.811, affinity 0.926, DiffDock -1.61。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Alvimopan - ADORA2B

Adenosine receptor A2b

专家先看这一句：Alvimopan 指向 ADORA2B 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：阿片药理和安全上下文会强烈影响解释，必须先证明候选靶点依赖，而不是泛 opioid 表型。

第一步实验：围绕 ADORA2B/Adenosine receptor A2b 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 2。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Alvimopan 是否能产生 ADORA2B 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.821, affinity 0.941, DiffDock -4.45。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Palonosetron Hydrochloride - CALCRL

Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor

专家先看这一句：Palonosetron Hydrochloride 指向 CALCRL 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 CALCRL/Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 11。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Palonosetron Hydrochloride 是否能产生 CALCRL 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.786, affinity 0.891, DiffDock -2.69。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Pazopanib Hydrochloride - FLT3

Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3

专家先看这一句：Pazopanib Hydrochloride 指向 FLT3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 FLT3/Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：有少量文献线索。PubMed drug-target 9, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 17。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Pazopanib Hydrochloride 是否能产生 FLT3 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.802, affinity 0.914, DiffDock -3.73。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Donepezil Hydrochloride - EDNRA

Endothelin-1 receptor

专家先看这一句：Donepezil Hydrochloride 指向 EDNRA 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：EDNRA 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 63。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Donepezil Hydrochloride 是否能产生 EDNRA 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.943, affinity 0.902, DiffDock -2.23。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Gefitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。

GPT 可行性判断：作为阳性对照保留，不作为候选发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 6,919, drug-target-disease 441, ClinicalTrials 药物-疾病方向 21。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Gefitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.971, DiffDock -0.77。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

Carbonic anhydrase 2

专家先看这一句：这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。

GPT 可行性判断：适合作为 enzyme assay 阳性对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。

Go/No-Go 门槛：必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout；若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 47, drug-target-disease 12, ClinicalTrials 药物-疾病方向 83。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dorzolamide Hydrochloride 是否能产生 CA2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.980, affinity 0.953, DiffDock 0.50。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Ramipril - GLP1R

Glucagon-like peptide 1 receptor

专家先看这一句：Ramipril 指向 GLP1R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 GLP1R/Glucagon-like peptide 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：有少量文献线索。PubMed drug-target 3, drug-target-disease 1, ClinicalTrials 药物-疾病方向 167。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Ramipril 是否能产生 GLP1R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.786, affinity 0.682, DiffDock -3.51。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Spironolactone - AR

Androgen receptor

专家先看这一句：Spironolactone 指向 AR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：AR response element reporter、经典 AR 靶基因表达和配体竞争实验。

Go/No-Go 门槛：必须看到 AR 依赖的剂量反应；若不能和激素背景或毒性区分则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 90, drug-target-disease 43, ClinicalTrials 药物-疾病方向 258。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Spironolactone 是否能产生 AR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.795, affinity 0.694, DiffDock -2.98。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Propranolol Hydrochloride - HTR4

5-hydroxytryptamine receptor 4

专家先看这一句：Propranolol Hydrochloride 指向 HTR4 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：建议进入专家讨论，但先做低成本靶点实验。

为什么可以考虑：新颖性较高，且靶点功能实验相对可执行；适合先用低成本实验判断是否有真实 target engagement。

为什么可能不值得做：不要直接做疾病细胞表型；如果靶点 readout 不成立，后续疾病实验没有解释力。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：HTR4 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：有少量文献线索。PubMed drug-target 13, drug-target-disease 7, ClinicalTrials 药物-疾病方向 270。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Propranolol Hydrochloride 是否能产生 HTR4 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.880, affinity 0.814, DiffDock -1.38。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Treprostinil - OPRM1

Mu-type opioid receptor

专家先看这一句：Treprostinil 指向 OPRM1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：OPRM1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 140。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Treprostinil 是否能产生 OPRM1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.807, affinity 0.711, DiffDock -2.64。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Doxazosin Mesylate - ADRB2

Beta-2 adrenergic receptor

专家先看这一句：Doxazosin Mesylate 指向 ADRB2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：Doxazosin 的 alpha-1 主药理很强，任何心血管或 GPCR 表型都必须用 ADRA1A counterscreen 排除混杂。

第一步实验：围绕 ADRB2/Beta-2 adrenergic receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：有少量文献线索。PubMed drug-target 1, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 39。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Doxazosin Mesylate 是否能产生 ADRB2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.949, affinity 0.910, DiffDock -2.77。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Labetalol Hydrochloride - ADRB1

Beta-1 adrenergic receptor

专家先看这一句：Labetalol Hydrochloride 指向 ADRB1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：围绕 ADRB1/Beta-1 adrenergic receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 98。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Labetalol Hydrochloride 是否能产生 ADRB1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.822, affinity 0.732, DiffDock -4.20。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Sacubitril - NPY5R

Neuropeptide Y receptor type 5

专家先看这一句：Sacubitril 指向 NPY5R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：NPY5R 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 238。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Sacubitril 是否能产生 NPY5R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.779, affinity 0.672, DiffDock -4.37。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Gefitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：这是经典 EGFR-TKI 正控召回，最适合证明筛选和实验读数能工作。

GPT 可行性判断：作为阳性对照保留，不作为候选发现。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 6,919, drug-target-disease 169, ClinicalTrials 药物-疾病方向 30。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Gefitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.843, affinity 0.971, DiffDock -0.83。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Methylnaltrexone Bromide - OXTR

Oxytocin receptor

专家先看这一句：Methylnaltrexone Bromide 指向 OXTR 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：OXTR 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 2。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Methylnaltrexone Bromide 是否能产生 OXTR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.878, affinity 0.810, DiffDock -1.90。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Atropine - CHRM1

Muscarinic acetylcholine receptor M1

专家先看这一句：Atropine 指向 CHRM1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：围绕 CHRM1/Muscarinic acetylcholine receptor M1 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 12, drug-target-disease 1, ClinicalTrials 药物-疾病方向 156。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Atropine 是否能产生 CHRM1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.826, affinity 0.948, DiffDock -2.67。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Solifenacin Succinate - CHRM3

Muscarinic acetylcholine receptor M3

专家先看这一句：Solifenacin Succinate 指向 CHRM3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CHRM3 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 5, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 21。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Solifenacin Succinate 是否能产生 CHRM3 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.871, affinity 0.800, DiffDock -2.45。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Amisulpride - ADRA1A

Alpha-1A adrenergic receptor

专家先看这一句：Amisulpride 指向 ADRA1A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接 **为什么可能不值得做：**当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：ADRA1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 51。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Amisulpride 是否能产生 ADRA1A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.895, affinity 0.834, DiffDock -2.40。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dextromethorphan Hydrobromide - KCNK9

Potassium channel subfamily K member 9

专家先看这一句：Dextromethorphan Hydrobromide 指向 KCNK9 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 KCNK9/Potassium channel subfamily K member 9 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 91。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dextromethorphan Hydrobromide 是否能产生 KCNK9 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.900, affinity 0.841, DiffDock -5.74。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Nalmefene Hydrochloride - DRD2

D(2) dopamine receptor

专家先看这一句：Nalmefene Hydrochloride 指向 DRD2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：DRD2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 14。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Nalmefene Hydrochloride 是否能产生 DRD2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.892, affinity 0.830, DiffDock -2.78。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Lumateperone Tosylate - TACR3

Neuromedin-K receptor

专家先看这一句：Lumateperone Tosylate 指向 TACR3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 TACR3/Neuromedin-K receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 1。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Lumateperone Tosylate 是否能产生 TACR3 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.859, affinity 0.784, DiffDock -4.12。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Umeclidinium Bromide - CHRM2

Muscarinic acetylcholine receptor M2

专家先看这一句：Umeclidinium Bromide 指向 CHRM2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CHRM2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 0，drug-target-disease 0，ClinicalTrials 药物-疾病方向 3。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Umeclidinium Bromide 是否能产生 CHRM2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.836，affinity 0.751，DiffDock -3.89。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Revefenacin - HTR2A

5-hydroxytryptamine receptor 2A

专家先看这一句：Revefenacin 指向 HTR2A 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：建议进入专家讨论，但先做低成本靶点实验。

为什么可以考虑：新颖性较高，且靶点功能实验相对可执行；适合先用低成本实验判断是否有真实 target engagement。 **为什么可能不值得做：**不要直接做疾病细胞表型；如果靶点 readout 不成立，后续疾病实验没有解释力。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：HTR2A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0，drug-target-disease 0，ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Revefenacin 是否能产生 HTR2A 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.893，affinity 0.831，DiffDock -3.44。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dacomitinib - EGFR

Epidermal growth factor receptor

专家先看这一句：这是已知 EGFR 抑制剂与 EGFR 的直接召回，和 Gefitinib 类似。

GPT 可行性判断：若预算有限，可在 EGFR 正控中只保留一个代表。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。 **为什么可能不值得做：**不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。

Go/No-Go 门槛：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 374，drug-target-disease 22，ClinicalTrials 药物-疾病方向 5。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dacomitinib 是否能产生 EGFR 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.808，affinity 0.922，DiffDock -1.15。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Olopatadine Hydrochloride - S1PR1

Sphingosine 1-phosphate receptor 1

专家先看这一句：Olopatadine Hydrochloride 指向 S1PR1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：抗组胺主药理和 GPCR off-target 容易混在一起，需要 H1 receptor 与同家族受体 counterscreen。

第一步实验：围绕 S1PR1/Sphingosine 1-phosphate receptor 1 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Olopatadine Hydrochloride 是否能产生 S1PR1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.888, affinity 0.824, DiffDock -0.74。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Palonosetron Hydrochloride - F2R

Proteinase-activated receptor 1

专家先看这一句：Palonosetron Hydrochloride 指向 F2R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：F2R 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 11。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Palonosetron Hydrochloride 是否能产生 F2R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.800, affinity 0.912, DiffDock -4.08。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Sumatriptan Succinate - SSTR3

Somatostatin receptor type 3

专家先看这一句：Sumatriptan Succinate 指向 SSTR3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 SSTR3/Somatostatin receptor type 3 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 116。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Sumatriptan Succinate 是否能产生 SSTR3 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.790, affinity 0.898, DiffDock -1.03。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Dasatinib - YES1

Tyrosine-protein kinase Yes

专家先看这一句：Dasatinib 指向 YES1 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是可靠的。
为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：围绕 YES1/Tyrosine-protein kinase Yes 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 29, drug-target-disease 1, ClinicalTrials 药物-疾病方向 32。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dasatinib 是否能产生 YES1 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.803, affinity 0.916, DiffDock -1.50。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Bosutinib Monohydrate - FYN

Tyrosine-protein kinase Fyn

专家先看这一句：Bosutinib Monohydrate 指向 FYN 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。
为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 FYN/Tyrosine-protein kinase Fyn 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Bosutinib Monohydrate 是否能产生 FYN 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.769, affinity 0.868, DiffDock -1.48。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Tivozanib Hydrochloride - CSF1R

Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor

专家先看这一句：Tivozanib Hydrochloride 指向 CSF1R 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。
为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：主要风险是靶点依赖性不足；必须先做直接功能或结合实验，再解释疾病表型。

第一步实验：围绕 CSF1R/Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 1。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Tivozanib Hydrochloride 是否能产生 CSF1R 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.769, affinity 0.868, DiffDock -2.88。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等同于体内疗效。

Azelastine Hydrochloride - CXCR2

C-X-C chemokine receptor type 2

专家先看这一句：Azelastine Hydrochloride 指向 CXCR2 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：保留为二线验证；先做低成本靶点或通路实验，结果清楚后再进入疾病模型。

为什么可以考虑：实验通常能做，但疾病方向或药理解释不够直接，需要专家确认机制链后再投入。

为什么可能不值得做：当前最大问题不是能不能测，而是测出来以后是否能讲清楚机制。

主要混杂因素：抗组胺主药理和 GPCR off-target 容易混在一起，需要 H1 receptor 与同家族受体 counterscreen。

第一步实验：围绕 CXCR2/C-X-C chemokine receptor type 2 设计直接结合或功能 readout。

Go/No-Go 门槛：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

排重状态：未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Azelastine Hydrochloride 是否能产生 CXCR2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.810, affinity 0.714, DiffDock -1.81。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

Carbonic anhydrase 2

专家先看这一句：这是碳酸酐酶抑制剂和 CA2 的已知机制召回。

GPT 可行性判断：适合作为 enzyme assay 阳性对照。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。

Go/No-Go 门槛：必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout；若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 47, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 0。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Dorzolamide Hydrochloride 是否能产生 CA2 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.830, affinity 0.953, DiffDock 0.70。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。

Umeclidinium Bromide - CHRM3

Muscarinic acetylcholine receptor M3

专家先看这一句：Umeclidinium Bromide 指向 CHRM3 的假设，需要先证明这个靶点确实被药物调节，再解释疾病表型。

GPT 可行性判断：只作阳性对照或流程校准。

为什么可以考虑：有清楚已知机制，能证明平台和实验 readout 是否可靠。

为什么可能不值得做：不是新用途/新靶点，不应占用太多探索预算。

主要混杂因素：主要问题不是可行性，而是新颖性低；用途是证明实验体系和筛选流程能找回已知药理。

第一步实验：CHRM3 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。

Go/No-Go 门槛：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

排重状态：已知机制或阳性对照。PubMed drug-target 0, drug-target-disease 0, ClinicalTrials 药物-疾病方向 3。

讨论问题：在非毒性、临床可达或体外合理浓度下，Umeclidinium Bromide 是否能产生 CHRM3 依赖的剂量反应，并被正交实验和 counterscreen 支持？

保留的关键数值：direction 0.818, affinity 0.758, DiffDock -4.56。这些数值只作排序/结构审阅辅助，不等于体内疗效。